2026학년도 산부인과 학년말고사 (260415)

* 60문제, 60분 시험(CBT)

1. 32세 산과력 0-0-0-0인 여자가 2년간 임신이 되지 않는다며 병원에 왔다. 월경주기는 28일로 규칙적이었다. 불임에 대한 검사로 혈액검사와 배우자의 정액검사 시행하였고 결과는 다음과 같다. 이 환자에 대해 시행할 수 있는 조치는?

-혈액: LH, FSH, Estradiol, 황체호르몬, TSH, Prolactin 정상 -자궁난관조영술: 정상 -정액: 정액량, 운동성, 형태 등 모두 정상 (참고치 주어짐)

① 자궁경부 문제일 수 있으므로 Postcoital test를 시행하여 경부 점액과 정자의 반응을 확인한다.
② 특별한 치료없이 기대요법(Expectant Management) 시 주기당 임신 성공 확률은 정상 부부와 동일하게 약 20-25%이다.
③ 현재 가이드라인 상 1차 치료로 clomiphene, 인공수정(iui) 3-4주기로 초기에 시도할 수 있다.
④ 1차 치료로 생식샘자극호르몬(Gonadotropin) 주사를 이용한 과배란유도를 시행한다.
⑤ 황체기 결함 등을 확인하기 위해 황체기에 자궁내막 조직검사(Endometrial biopsy)를 시행하여 자궁내막 조직연대측정(Endometrial dating)을 한다.

2. 35세 여자가 8개월 전부터 월경이 없어서 병원에 왔다. 9개월 전 계류유산으로 자궁긁어냄술을 받은 후 점차 월경량이 줄었다고 한다. 소변 임신반응검사는 음성이다. 안면홍조, 불면증 등의 증상은 없었고 혈액검사 상 호르몬 수치는 모두 정상이었다. 원인을 감별하기 위해 시행한 프로게스테론 부하검사에서 소퇴성 출혈은 없었다. 이 환자에 대해 옳은 것은?
① 진단+치료를 위해 자궁경을 해야한다.
② 이어서 에스트로겐-프로게스테론 부하 검사를 시행하면 소퇴성 출혈 있을 것이다.
③ HPO axis와 직결되는 문제다.
④ 수술 후 4주간 프로게스테론 단독요법 시행해야 한다.
⑤ 항뮐러관 호르몬 검사를 해야한다.

3. 24살 여성이 질출혈 심해서 내원하였다. 1년간 생리 3~4번 하는 희소월경이었고 최근 3개월간 월경이 없었다. Hb 9.2였으며 질식초음파 상 자궁내막 3mm로 심하게 박리되어 있었다. 질출혈에 대한 일차치료로 사용할 수 있는 약물로 옳은 것은?
① 고용량 에스트로겐
② 고용량 프로게스테론
③ 레보노게스트렐-자궁내 장치
④ NSAIDs
⑤ 선택적 에스트로겐 수용체 조절제

4. 50세 여자가 안면홍조, 불면으로 병원에 왔다. 3년전 severe endometriosis로 TAH+BSO를 받은 병력이 있다. 혈액검사 결과는 중성지방과 LDH 상승한 소견을 보였다. 이 환자의 치료로 사용할 수 있는 약물로 옳은 것은?
① 티볼론
② SSRI, SNRI
③ 경피 에스트로겐 + 프로게스테론
④ 경구 에스트로겐
⑤ 에스트로겐 단독요법 (ET)

5. 28세 여성이 생리 7-10일 전부터 불안감과 우울, 짜증의 기분이 났으며 월경 직전 복부팽만감 및 부종이 있어 내원하였다. 생리주기와 증상이 관련있는지 확인하기 위해 'COPE 설문지'를 매일매일 기록하게 하였고, 생리주기와 관련있는 것이 확인되었다. 기분 저하와 관련된 증상이 일상생활에 지장이 갈 만큼 증상이 심하였다. 치료로 적절한 것은?
① TCA
② SSRI + 스피로노락톤
③ 달맞이꽃오일과 식이제한
④ 비타민D 등 보조제만 복용
⑤ 레보노게스트렐 자궁내장치

6. 55세 여자가 소변이 마려우면 화장실에 도달하기 전에 소변이 나와 병원에 왔다. 기침이나 재채기를 할 때 소변이 새지는 않았다고 한다. 소변검사와 골반 초음파 검사는 정상이었고, Q tip 검사는 15도였다. 요역동학검사상 방광의 불수의적 수축이 있으면서 소변누출이 관찰되었다. 진단은?
① 절박성 요실금
② 신경탓 방광
③ 긴장성 요실금
④ 범람 요실금

7. 5세 여아가 유방이 발달하고 소량의 질출혈을 보여 내원하였다. 유방 tanner stage 3, 음모 tanner stage 1기였다. 목 뒤쪽에 커피색의 반점(Cafe au lait spot)을 보였다. 검사결과는 다음과 같다. 진단은?

-골연령 8세 -에스트라디올 55 (높음), LH/FSH 낮음 -GnRH 자극검사 → LH 1.5 (상승) -TSH 정상, prolactin 정상

① McCune-Albright syndrome
② Congenital adrenal hyperplasia
③ 조기 부신 조숙증
④ 뇌하수체 과오종

8. 45세 환자가 의식혼수로 응급실에 내원하였다. 2시간 전 개인병원에서 자궁근종으로 자궁 절제술을 받았는데 수술 과정에 특별한 문제는 없었으나 수술 시간이 예상보다 오래 걸렸다고 한다. 넣어준 수액의 주입량과 배출량은 각각 6000cc, 1000cc이다. 다음 중 원인이 된 distention media로 가장 가능성이 높은 것은?
① Dextran 70
② CO_2
③ 3% sorbitol
④ Normal saline
⑤ 5% mannitol

9. 32세 여성으로 2년간 임신이 되지 않아 내원하였다. BMI 28로 비만이었고 턱쪽에 굵은 털이 나는 다모증이 있었으며, 1년에 생리 3-4번하는 희소월경이었다. 골반 초음파에서 난소에 20개의 낭종이 관찰되었다. 질병에 대한 치료로 최근 체중감소 5% 해냈으나 난임이 지속되어 약물치료를 시도하고자 한다. 배란을 유도하고 Live birth와 임신 성공률을 극대화하기 위해 사용하는 약물은?
① Metformin
② Letrozole
③ Clomipen citrate

10. 16세 여성이 일차성 무월경으로 내원하였다. 키는 또래 평균보다 컸고 유방은 발달되어있으나 겨드랑이와 음모는 거의 관찰되지 않았다. 초음파 상 자궁과 자궁경부, 난소가 관찰되지 않았고 내진 상 질이 짧고 상부가 막혀있었다. 진단은?
① Complete androgen insensitivity syndrome
② Swyer syndrome
③ Mullerian agenesis

11. 24세 여자가 월경이 없어서 병원에 왔다. 평소 생리는 1년에 3~4번 정도로 희발월경을 보였고 턱에 굵은 수염이 나는 모습을 보였으며, BMI 29kg/m^2으로 비만이었다. 목 뒤 피부는 갈색이었다. 학업 진행 중으로 임신계획은 없다고 한다. 이 환자에 대해 옳은 것은?
① 임신계획 없으므로 프로게스테론 단독으로 치료한다.
② 진단을 위해 반드시 한쪽 난소 cyst 20개 이상 발견되어야 한다.
③ 대사이상은 공복혈당만 확인하면 된다.
④ 체중 줄이는 것은 간에서 SHBG을 오히려 늘려 고안드로겐을 보여 약물치료가 우선이다.

12. 33세 여자가 피임을 위해서 병원에 왔다. 평소 월경주기는 28일로 규칙적이었다. 2개월 전 골반염을 진단받아 치료받았다. 사용 불가능한 피임방법은?
① 자궁 내 장치
② 경구피임약
③ 콘돔
④ 기초체온법
⑤ 피임용 격막

13. 앙와위에서 자궁의 윤곽을 파악하는 수기로, 자궁 저부와 하고 자궁 옆면을 촉진하고 태아의 팔다리 방향을 확인하는 것으로 태축, 태위, 태향 등을 알 수 있음. 양수과다증이 있거나 산모가 비만일 경우 판단하기 어려움. 이 수기는?
① 맥로버트
② 리트겐
③ 모리쉐
④ 레오폴드
⑤ 피나드

14. 진통 억제제 중 다음과 같은 특성을 가지는 것은?

- 칼슘 길항작용 - 과량 작용 시 호흡부전 유발 가능 - 신장으로 배설 - 태아 neuroprotective

① 리토드린
② 황산마그네슘
③ Terbutaline

15. 임신 39주의 산모가 질식분만 후 다량의 질출혈이 계속되었다. 자궁저부는 배꼽 밑에서 단단하게 만져졌고, 만출된 태반 역시 정상이었다. 가장 가능성 높은 진단은?

① 자궁목열상

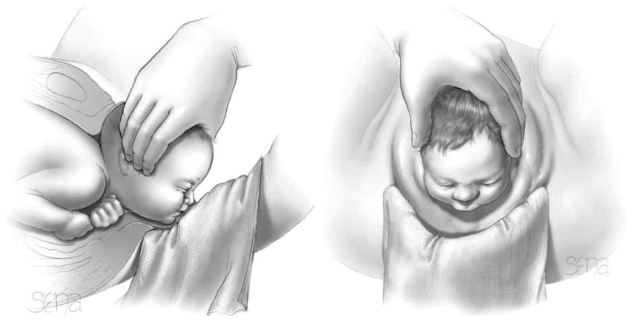
② 잔류태반

③ 자궁근무력증

④ 자궁내번증

⑤ 양수색전증

16. 다음 그림은 분만 2기에 시행하는 특정 수기를 나타내고 있다. 이 수기를 통해 분만 시술자가 태아의 턱을 밀어 올리며 가장 직접적으로 조절하거나 유도하고자 하는 분만 기전(cardinal movement)은?



① 진입 (Engagement)

② 하강 (Descent)

③ 굴곡 (Flexion)

④ 신전 (Extension)

⑤ 외회전 (External rotation)

17. 태아의 양쪽머리뼈지름(BPD)이 골반 입구 통과할 때 아두 위치는?

① -2

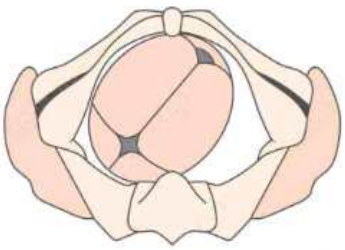
② -1

③ 0

④ +1

⑤ +2

18. 다음에 해당하는 Fetal orientation은?



① ROA

② LOA

③ ROP

④ LOP

⑤ OA

19. 임신 10주인 27세 임산부가 전날부터 시작된 소량의 질출혈을 주소로 병원에 내원하였다. 하복부 통증이나 골반통은 호소하지 않았다. 활력징후는 혈압 110/70 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.6도였다. 골반내진 시 자궁경부 개대는 확인되지 않았으며, 골반 초음파 검사상 임신낭이 확인되었다. 태아 심박동이 확인되었다. 이 환자의 진단으로 가장 적절한 것은?

① 절박유산

② 불완전유산

③ 계류유산

④ 불가피유산

⑤ 완전유산

20. 26세 임신 37주의 임산부가 병원에 내원하였다. BPP가 8점이었고, single vertical pocket 의 크기가 2cm 였다. 해야할 조치는?

① 1주 뒤 생물리학계수 측정

② 1주 뒤 비수축 검사, 양수량 측정

③ 응급제왕절개

④ 분만

⑤ 경과관찰

21. 34세 임신 36주인 산모가 심한 두통으로 내원하였다. 혈압 180/110mmHg, 단백뇨 4+, 부종 (2+, 2+), 자궁 경부 1cm 개대, 80% 소실되었고 BPP score 8점이었다. 알맞은 처치는?

① 분만

② 경과관찰

③ 글루코코르티코이드

④ 황산마그네슘

⑤ 푸로세마이드

22. 17세 여성 환자가 무월경으로 내원하였다. 복통을 호소하였고 미세한 출혈이 있었다. 다음으로 진행해야 할 검사는?

① 임신 검사

② 복강경 검사

③ 자궁경 검사

④ 프로게스테론 부하 검사

⑤ FSH/LH 검사

23. 임신 8주 여성이 n시간 전 시작된 하복부 통증과 다량의 질출혈을 주소로 내원하였다. 내원 전 대형 패드를 1시간 간격으로 교체할 정도로 출혈이 심했다. 골반 검사에서 심한 출혈이 확인되었으며, 골반초음파 시행 시 임신낭은 보이지 않았고, 자궁경부는 열려 있었으며, 자궁 내강에 수태물이 확인되었다. 추후 시행할 처치로 가장 적절한 것은?

① 경과관찰
② D&C
③ 프로게스테론
④ MTX
⑤ Misoprostol

24. 여성 환자가 이소성 임신으로 인해 한쪽 난관 절제술을 받았다. 이후에 피임을 원할 때 골라야하는 피임법은?

① 콘돔
② 피임용 격막
③ 복합경구피임제
④ 구리자궁내장치
⑤ 레보노게스트렐 자궁내장치

25. 30세 산모가 40주에 정상 질식 분만 하였다. 분만 후 추가적인 출혈은 없었다. 태아 분만 후 1분이 경과하였으나, 아직 태반은 만출되지 않았다. 복부 촉진 시 자궁 저부는 딱딱하게 만져졌다. 현재 시점에서 시행해야 할 가장 적절한 처치는?

① 탯줄 견인
② 자궁 저부 압박술
③ 태반용수박리
④ 옥시토신
⑤ 더 기다린다

26. 29세 임신 9주인 경산모가 산전 진찰을 위해 내원하였다. 활력징후는 혈압 110/70 mmHg, 맥박 70회, 호흡 수 16회, 체온 36.5도였다. 산모는 이전 임신에서 임신성 당뇨병으로 진단받고 인슐린 치료를 받은 이력이 있다. 이 산모에게 현재 시행해야 할 가장 적절한 조치는?

① 경과관찰
② 50g OGTT
③ 100g OGTT
④ 인슐린 투여

27. 임신 7주 산모가 Pap smear 검사에서 HSIL, HPV 18+ 소견으로 병원에 왔다. 산모에게 시행할 처치로 가장 적절한 것은?

① 매 산전진찰마다 세포 검사, HPV 검사를 시행
② 13주차에 환상전기절제술을 시행
③ 경과관찰
④ 즉시 ablation
⑤ 출산 후 6주에 치료

28. 29세 미분만부가 1주일 전 시작된 질출혈을 주소로 내원하였다. 활력징후는 안정적이었다. 골반초음파에서 자궁 내 포도송이 모양의 고에코 소견이 관찰되었으며, 우측 부속기에서 약 7cm의 낭성 종괴가 확인되었다. 혈청 beta-hCG는 100,000 mIU/mL로 확인되었다. 이 환자에게 시행해야 할 가장 적절한 처치는?

① 흡인긁어냄술
② 자궁절제술
③ 단일함암치료
④ 복합항암치료
⑤ MTX

29. 임신 36주차의 건강한 산모가 수술 전 외래에서 오전에 금식하고 시행한 혈액 검사가 다음과 같았다. 이상 소견은 무엇인가?

Na	135
K	3.9
Cl	105
protein	5.9 ▽
albumin	2.7 ▽
Ca	8.8
P	3.9
Cholesterol	282 △
Glucose	115 △
ALP	136 △
AST	28
ALT	17
CRP	0.4

① Glucose
② ALP
③ Cholesterol
④ Protein
⑤ Albumin

30. 임신 시 일어나는 모체의 생리적 변화로 옳은 것은? (중복정답 처리)
① 유방의 크기가 클 수록 모유 생성량이 증가한다.
② 임신시 질의 산도는 pH 6~7을 유지한다.
③ 정상 산모에게 Angiotensin 2을 주입해도 혈압이 상승하지 않는다.
④ 임신 시 albumin 양 증가
⑤ 임신 시 산모는 태아에게 원활하게 glucose를 공급하기 위해 약간 diabetogenic한 상태가 된다.

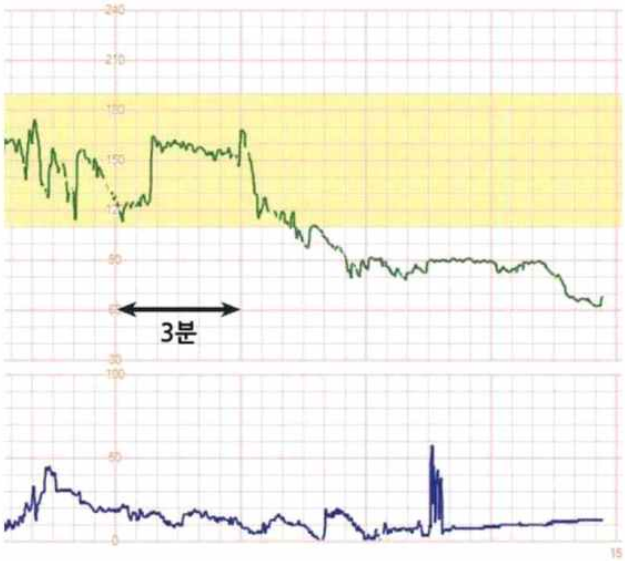
31. 다음 사진과 같이 어깨를 누르면서 분만해야 하는 이유로 옳은 것은?



① GDM
② 미숙아
③ 양수과다증
④ 전치태반

32. 31주 32세 임산부가 숨이 차고 다리가 부어 내원하였다. 혈압 110/80, 맥박 70/분, 호흡 25 회/분이었다. 복부 촉진상 태아의 신체부위가 안 만져질 정도로 복벽이 팽팽하였고 자궁바닥의 높이는 38cm, 양수지수는 32 이었다. 처치는?
① Indomethacin
② 분만
③ 수분제한
④ Furosemide

33. 35주 임산부가 아기가 잘 놀지 않는다는 것을 주소로 내원했다. Fetal CTG 시행 시 다음과 같은 양상이 나타났다. 처치는?



① c/sec
② 경과관찰
③ 옥시토신
④ 양수주입
⑤ 옆누운자세로 변경

34. 34세 다분만부가 한쪽 유방이 아프고 화끈거려서 내원하였다. 3주 전에 질식분만하여 수유를 지속하고 있었으며 체온은 38.4℃이다. 농양은 관찰되지 않고 발적과 발열은 있을 때, 시행할 처치로 옳은 것은?



(비슷한 사진이 나왔음)
① 경과 관찰
② 모유생성억제제
③ 항생제
④ 농양배액술
⑤ 수유 중단

35. 35세 24주 단일융모막 쌍태임신 산모의 초음파 소견이다. 치료는?

	태아체종	AFV	성별	방광	탯줄동맥도플러	MCA
태아 1	200 (10분위)	2	여	보임	보임	보임
태아 2	800(70)	8	남	보임	보임	보임

① 사이막절개술
② 경과관찰
③ 혈관문합 레이저절개술
④ 양수 감압술
⑤ 선택유산

36. 임신 17주 산모의 초음파 검사 결과가 다음과 같았다. 산모는 이전 임신 시 조산을 한 과거력이 있다. 환자에게 다른 이상은 없을 때 시행해야 할 처치로 가장 적절한 것은?



① 경과관찰
② 자궁경부봉축술
③ 프로게스테론
④ 니페디핀

37. 태아 DNA 선별검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 35세 미만 저위험군 임산부에게 가장 적절한 검사는 '태아 DNA 선별검사'가 아니라 '모체혈청 선별 검사'이다.
나. 모체 혈액 내 태아 DNA는 임신 4주부터 검출되는 200bp 이하의 작은 조각이며 분만 후 2시간 이내에 모체의 혈액으로부터 사라진다.
다. 태아 DNA 선별검사는 임신 8주 이후에 시행하는 것이 좋다.
라. 상염색체 수적이상, 성염색체 수적이상, 그리고 미세결실의 선별검사에 활용할 수 있다.

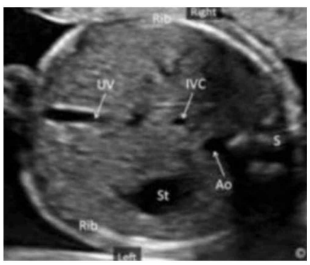
① 가나다라
② 가나다
③ 가다
④ 나라
⑤ 라

38. 산과력이 0-2-0-1인 27세 임산부가 정기적으로 산전진찰을 받아오던 중 임신 16주 aFP 검사결과가 2.8MoM이 나왔다. 할 수 있는 검사로 옳은 것은?

가. 기본 초음파 검사를 다시 시행하여 임신 주수를 재확인한다.
나. 임신주수가 확실하다면 양수천자 검사를 시행해야 한다.
다. 양수 내 aFP와 양수 내 acetylcholinesterase를 측정한다.
라. 정밀 초음파 검사를 실시한다.

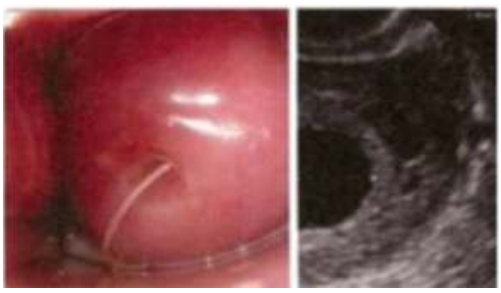
① 가다
② 나라
③ 가나다
④ 라
⑤ 가나다라

39. 다음 사진은 fetal biometry 중 어느 부위를 측정하는 것인가?



① 태아머리둘레
② 대퇴골길이
③ 복부둘레
④ 양쪽마루뼈지름
⑤ 머리엉덩둘레

40. 39세 산과력 0-0-3-0 여성이 무월경으로 내원하여 hCG 검사를 시행한 결과 양성이었다. 1년 전 자궁내장치 시술을 받았다. 질경검사 사진과 초음파 검사 사진이다. 처치는?



① 프로게스테론 투여
② 경과관찰
③ 입원 후 융모막 융모 생검
④ 항생제투여
⑤ IUD 제거

41. 다음 약물에 대한 설명 중 옳은 것을 고르시오.

가. 여드름 치료제인 isotretinoin은 neural crest cell의 이동을 방해하여 25~35%에서 선천적 기형을 유발할 수 있으며, 반감기가 50시간이므로 임신 최소 1달 전에는 사용 중단을 권고한다. 나. 조울증 치료제인 Lithium은 Ebstein's anomaly 심장 기형을 발생시킬 수 있으며, 분만 직전 24~48시간에는 신생아 리튬 독성을 예방하기 위해 복용을 중단해야 하고, 필요하다면 출산 후에 다시 복용할 것을 권고한다. 다. 항경련제인 valproic acid는 FDA class D에 해당하는 약물로 임신중이더라도 최소 용량으로 단일 제제로 사용하면 안전하고 임신 3개월 전부터 엽산을 복용하면 기형을 예방할 수 있다. 라. SSRI 제제인 Paroxetin은 VSD 등 심장기형 위험이 1.5배 증가하므로 임신 중 복용 금기이다.

① 가나다라
② 가나다
③ 가다
④ 나라
⑤ 라

42. 모자보건법 상 대통령령 15조에 의거한 인공임신중절수술의 허용한계가 아닌 것은?
① 본인이나 배우자가 우생학적 또는 유전학적 정신 장애나 신체질환이 있는 경우
② 본인이나 배우자가 대통령령으로 정하는 전염성 질환이 있는 경우
③ 강간 또는 준강간에 의하여 임신된 경우
④ 임신의 지속이 보건의학적 이유로 모체의 건강을 심각하게 해치고 있거나 해칠 우려가 있는 경우
⑤ 태아의 유전학적 또는 염색체 이상 등의 질환이 있는 경우

43. 환자가 치료받고자 하는 문제에 대해 시간 순서대로 명시한 것. 어디가 아프고 onset, duration 등등 언제 악화되고 언제 완화되는 지 등 알아보는 것과 관련된 사항은?
① Present illness
② C.C
③ initial assessment
④ physical examination
⑤ ROS

44. 자궁경부암 환자의 수술 사진이다. 화살표로 표시한 구조물은?

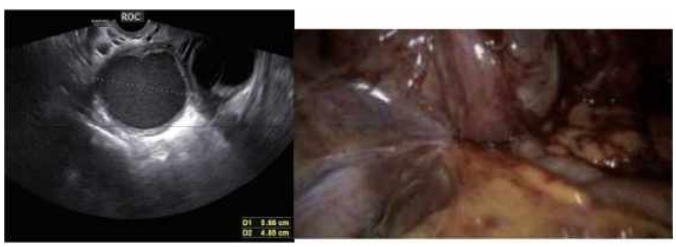


① left ureter
② left obturator nerve
③ left uterine artery
④ left external iliac vein
⑤ left external iliac artery

45. 산과력 3-0-4-3인 55세 여성이 성교 후 질 출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과 HSIL이었다. 자궁 경부에 2~3cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 침윤성 편평세포암종이었다. 다음으로 시행할 적절한 조치는?
① 단순 전자궁적출술
② 이미 conization을 실시하였으므로 경과를 관찰한다.
③ 다시 conizaiton을 실시한다.
④ 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
⑤ 변형된 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술

46. 다음 사진에서 보이는 근종의 FIGO classification으로 적절한 것은?
- 답은 7일 가능성이 높음. 사진 못 찾음.

47. 초음파 소견상 간유리 같은 음영이 보였다. 초음파 소견과 복강경 소견은 다음과 같다. 진단은?



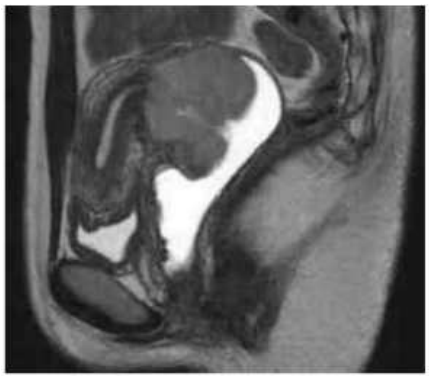
① 자궁내막증과 곧창자와 난소 유착
② 자궁근종
③ 자궁내막암

48. 산과력이 2-0-3-2인 45세 여자가 질 출혈을 주소로 내원하였다. 이전에 HSIL로 판명되어 conization을 시행했다. Colposcopy 결과 깊이 2mm, 너비 6mm인 자궁경부 침윤성 편평세포암종이 발견되었다. 환자가 더 이상 임신할 계획이 없다고 할 때, 적절한 치료는?



① 전자궁적출술
② 정기적 추적관찰
③ 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
④ 변형된 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
⑤ 전골반내용적출술

49. 산과력 2-0-1-2인 60세 여성이 질 출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과가 HSIL 이었다. 자궁경부에 3~4cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 침윤성 편평세포암종이었다. 진찰 및 MRI 소견이다. 다음으로 시행할 적절한 조치는?



① 단순 전자궁적출술
② 동시항암화학방사선치료
③ 정기적 추적관찰
④ 근치적 자궁절제술, 양측 난소난관절제술, 골반 림프절 절제술
⑤ 변형된 근치적 자궁절제술, 양측 난소난관절제술, 골반 림프절 절제술

50. 산과력이 2-0-1-2인 60세 여성이 자궁경부암으로 치료를 받았다. 근치적 자궁절제술 및 배막뒤림프절절제술을 시행했는데, 수술 소견은 다음과 같다. 골반강 근처 림프절은 전이되었지만 대동맥 근처 림프절은 전이되지 않았다. 환자의 병기와 다음으로 해야 할 처치는?
① IIC, 면역요법
② IIIC1, 항암화학요법
③ IIIC2, 항암화학요법
④ IIIC1, 동시항암화학방사선치료
⑤ IIIC2, 동시항암화학방사선치료

51. 다음 복강경 자궁 수술 시야 사진에서 보이는 구조물을 순서대로 쓰시오.



① Cardinal ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right ovary-Right infundibulopelvic ligament
② Cardinal ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right salpinx-Right infundibulopelvic ligament
③ Round ligament-Uterus-Left ovarian ligament-Left ovary-Left infundibulopelvic ligament
④ Round ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right salpinx-Right infundibulopelvic ligament
⑤ Round ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right ovary-Right infundibulopelvic ligament

52. 20세 대학생이 3시간 전부터 시작된 극심한 좌하복부 통증으로 응급실 방문하였다. 활력징후 110/70-75-24-36.9였고, 마지막 생리일은 2주 전이었고, 성경험은 있었다. 응급실에서 시행한 CT 소견이 다음과 같다면, 올바른 진단은?



① 난소 기형종
② Endometrial sinus
③ Endometrial hyperplasia

53. 다음 MRI 사진의 PALM-COEIN 소견은?



① AUB-A
② AUB-L
③ AUB-M
④ AUB-P
⑤ DUB

54. 다음은 수술 후 시행한 조직검사의 결과이다.

Uterus, endometrium, total hysterectomy: Endometrioid carcinoma with 1) Tumor site: Endometrium 2) Tumor size: 2.1x1.3 cm 3) Histologic grade: FIGO grade 2 4) Washing cytology (+), Lymphovascular invasion (+)

위 환자의 병기로 옳은 것은?
① FIGO stage IIIB
② FIGO stage IIIC1(i)
③ FIGO stage IIIC1(ii)
④ FIGO stage IIIC2

55. 26세 0-0-0-0 기혼 여성, 임신 7주, 산전 진찰에서 자궁경부 검사에 이상이 있어 내원하였다. 자궁경부암 선별검사에서 HSIL, 조직검사에서 LSIL로 확인되었다.

- Colposcopy 사진 주어짐 - HPV: 18번 양성

① 분만 6주 뒤로 치료를 미룬다
② LEEP 시행
③ 매주 산전진찰로 재검사
④ ablation

56. 55세 여성이 multiple myoma로 자궁근종 절제술을 시행했다. 수술 시간은 5시간이 소요되었으며, 떼어낸 근종은 총 700g이었다. 수술 후 foot drop 증상이 나타났으며, 다리를 질질 끄는 모습이 관찰되었다. 위 환자에서 손상된 신경으로 가장 적절한 것은?
① pudendal n.
② peroneal n.
③ obturator n.
④ femoral n.
⑤ sciatic n.

57. 17세 여학생이 복부통증이 있어 응급실로 봤다. 수술 소견에서 혈복강이 심하였고, 종양 표지자 검사가 다음과 같을 때, 환자에게 적절한 치료가 아닌 것은?

CA 125	216.6 IU/ml
CA 19-9	11.7 IU/ml
AFP	14472 ng/ml
β-hCG	〈0.1 mIU/ml

① Unilateral oopherectomy
② 반대쪽 난소가 정상이면 biopsy 하지 않는다
③ Stage IA이기 때문에 항암요법을 시행하지 않는다.
④ 방사선 치료는 하지 않는다.
⑤ 조직검사상 Schiller-Duval body가 보인다.

58. 39세 여성이 맑은 질분비물을 주소로 내원하였다. 밤에 잠을 잘 때도 나왔다. 3개월 전 전자궁 및 양쪽 부속기 절제술을 받았으며, 수술 다음날에 도뇨관을 제거하였다. 질분비물에 대해 인디고카민 정맥 주사 후 질에 거즈를 대보니 파란색으로 염색되었다. 가장 가능성 높은 진단은?
① 방광질샛길
② 긴장성 요실금
③ 절박요실금
④ 범람요실금
⑤ 과민성방광

59. 부인과 문제. 수술 후 허벅지 안쪽 감각 없어졌다. 수술하고 어떤 구조물에 이상 생긴 것일까?
(사진에서 obturator n. 고르는 문제였는데 표시된 구조물 중 신경은 하나밖에 없었음)
① (obturator n. 가리킴)

60. 임신 33주, 산과력 0-0-0-0인 산모의 태아 doppler 검사에서 Reversed end diastolic flow가 관찰되었다. 시행할 처치로 가장 적절한 것은?
① 1주 뒤 생물리학계수 측정
② 1주 뒤 재검사
③ 분만
④ 경과관찰